

골든링크 아키텍처 정리 (화이트보드 논의본)

전체 흐름

- 1

통화 시작

Rescue Team(구급대원·구급차)이 Hospital A(최초 통화 병원)와 통화 연결
- 2

음성 처리 (LLM)

통화 음성을 LLM이 처리 → 외상 정보 + 예상 병명 텍스트 생성 (처리 시간 소요)
- 3

GPS 전송

통화 시점의 구급차/구급대원 휴대폰 GPS를 즉시 HUB로 전송
※ GPS는 일정 주기 갱신 + 구급대원 수동 새로고침으로 재로딩
- 4

Hospital Info DB (상시 대기)

병원별 정보를 담은 DB — 병원명, 의사(이름·전공·수술 이력), 병원 GPS, Bed 수, Prof(야간 당직), 입퇴원 환자 Info(수술 병명·집도의, 개인정보 블라인드 처리)
※ 현재는 가안 데이터로 구축 예정, 추후 병원·구급대원 인터뷰로 보완
- 5

LLM/LSTM (병원 DB 처리)

Hospital Info DB의 정보를 HUB가 필요로 하는 형태로 실시간 가공해 전달
- 6

HUB — 1차 처리

GPS + Hospital Info DB → 거리 기준 Zone(1/2/3) 분류 → 거리순 병원 리스트 생성
※ Zone 거리 기준은 아직 미정
- 7

HUB — 2차 처리

외상·예상 병명 텍스트 도착 시 → 거리 리스트에 병원별 전문성(진료과·수술 이력)을 결합해 재정렬(스코어링)
- 8

대시보드 전송

HUB → Dash A(전체 병원) / Dash B(구급대원) 동시 전송
- 9

승인 절차

● Dash A: 병원이 수용 가능 시 **승인** 버튼

● Dash B: 구급대원이 승인 현황 확인 후 **임시 승인**(전환 가능) 또는 **이송 승인**(확정)

● 임시 승인 사용 이유: 처음 잡은 병원이 Zone3에 있을 때, 이동 중 더 가까운 병원이 승인하면 전환 가능하게 하기 위함

● 이송 승인 사용 이유: 처음부터 Zone1의 가까운 병원이 잡혀 다른 병원 승인이 있어도 전환할 필요 없을 때 확정하기 위함

확정된 사항 (오늘 논의)

- Hub의 매칭 로직(거리 순위, 전문성 스코어링)은 **규칙 기반**으로 처리하며, AI(LLM)는 사용하지 않는다
- AI가 담당하는 부분은 voice 브랜치의 음성 처리(STT + 병명·중증도 키워드 추출)까지이며, 그 결과를 JSON으로 Hub에 전달한다
- Hospital Info DB의 "입퇴원 환자 Info"는 병상 계산용이 아니라, 수술 병명·집도의 정보(개인정보 블라인드 처리)를 통한 병원별 전문성 판단용이다
- 병원 DB 구조는 가안이며, 팀원 회의와 실제 병원·구급대원 인터뷰를 거쳐 확정 예정이다